# El malestar es común.
# Llegar a ayuda, no.

**24 %**

en nivel **alto** de síntomas de ansiedad y depresión.

**50 %**

en nivel **moderado**. Juntos, **tres de cada cuatro**.

Valle-Palomino et al. 2024, BMC Psychology · 1 243 estudiantes de 6 universidades de Piura · muestreo probabilístico · son niveles de una escala, no diagnósticos.

La tesis

# No detectamos estrés. Acortamos el camino.

**SISCO**

Medida principal, validada en 628 universitarios de Lima.

**Tecleo**

Señal exploratoria, rotulada en pantalla. Solo contigo mismo.

**Una persona**

Un clic al servicio que la UPCH ya tiene.

## Demo · corre entera en el navegador, sin servidor

Video de la demo (4:30)

En vivo: ichisieben.github.io/pulso-upch/demo/

Lo que la evidencia dice y lo que no

# Nuestra idea original no se sostenía.

## ρ = 0,078

**Tecleo → estrés, entre personas.**

Casi azar. 36 empleados, 8 semanas.

**No dice** que nunca servirá.

## 3,3 %

**sigue usando una app de salud mental al mes.**

93 apps.

**Por eso** medimos el puente, no el uso.

## 28 → 58 %

**creyó tener un trastorno tras informarse.**

La educación nocebo redujo el aumento a la mitad.

**No dice** que dure: es TDAH, una semana.

## Predecir ≠ ayudar

**La alerta acertó; el abandono no bajó.**

Experimento aleatorizado, Países Bajos.

**Por eso** medimos el tiempo hasta una consulta.

Y la misma vara para nosotros: el detector acierta **90 de 90** en datos sintéticos, porque el cambio lo construimos grande. Si lo achicamos a un tercio, detecta **3 de 30**. Viabilidad técnica, no validez clínica.

Naegelin et al. 2025 · Baumel et al. 2019 · Sandra et al. 2025 · Plak et al. 2022 · detalle en docs/evidencia.md

Indicadores del piloto

# Medimos el puente y el daño. No la precisión.

| | |
|---|---|
| **Tiempo hasta la primera consulta atendida** PRIMARIO | Días entre la derivación en la app y la cita asistida, contra la línea base del servicio. |
| **Conversión a cita asistida** | Citas asistidas / derivaciones, a 14 días. |
| **Retención real a 30 días** | Se declara aunque sea mala. Referente: 3,3 %. |
| **Estrés pre/post** | SISCO al inicio y a las 8 semanas, por intención de tratar. |
| **Autoetiquetado y daño iatrogénico** | "Creo que tengo un problema de salud mental", antes y después. |

Qué pedimos

# Dos cosas que no tenemos, dichas claro.

## Convenio con Bienestar Estudiantil

Propuesto, no coordinado. Un canal de citas para el botón y la línea base del tiempo hasta la primera consulta. Hoy el botón lleva a la página pública de Bienestar.

## Comité de ética

Protocolo, consentimiento y evaluación de riesgos ante el Comité Institucional de Ética de la UPCH. Aún no presentado. Sin eso no hay piloto.

## Pulso UPCH no diagnostica. Acorta el camino hasta una persona.